

Que 101 años no es nada

“Una bella ancianidad es ordinariamente, la recompensa de una bella vida”
(Pitágoras) 569 a C. a 475 a C.

-Paciente: (por teléfono). Doctor, necesitaría un certificado que acredite que, con mis 101 años, estoy en condiciones para un trámite de transmisión de herencia.

-Médico: como ya transcurrió un año desde que lo revisara, necesitaría entrevistarlo, para examinarlo y hacerle un pequeño test.

-Paciente: mi hija está con algunos problemas, y no puede acompañarme. Yo camino algo inestable. ¿Podría visitarme en mi casa?

*¿Por qué somos clínicos
los clínicos?
Y otras reflexiones*

CARLOS ALBERTO YELIN

DIVULGACIÓN MÉDICA



Prólogo Daniel Flichtentrei.
Director editorial de Intramed

Ante la solicitud de quien asisto desde hace alrededor de 30 años, me presento en su domicilio, y al dejar el ascensor me espera en el dintel de la puerta abierta, Don Julio, con vestimenta impecable, y un aspecto general elegante. Al sentarme, y ver la raya perfecta de su pantalón, la elegancia de su camisa y el brillo de sus mocasines, miro las arrugas del mío, y mis zapatillas poco prolijas.

-¡Qué bien se lo ve Don Julio!...-Mientras pensaba jocosamente en ese momento, que podía adelantarme a hacer el certificado. Al iniciar la charla, sentados en la mesa del living del departamento que debía escriturar, le explico que necesitaba hacerle una “mini-prueba de estado mental”, (MMSE, sigla de *Mini Mental State Examination*) que consiste en una combinación de preguntas, que podrían parecerle algo inocentes para su conocida capacidad. Nosotros los clínicos, ese test lo solemos utilizar cuando los enfermos se quejan de déficit de memoria, con el objeto de tener una aproximación acerca de la validez del síntoma, tan frecuente en la consulta cotidiana.

Esa mini-prueba se practica partiendo de básicas preguntas sobre el día, mes, año, estación del año, para luego ampliar con otras, más complejas, que exploran la capacidad de abstracción, registros, y pequeños cálculos. Un puntaje se adjudica a cada una de las preguntas y luego se obtiene una suma, que se compara con el estándar de normalidad, establecido por quienes la crearon: M. Folstein, S. Folstein y P. Mc Caugh en 1976. Nuestro centenario amigo, para un puntaje ideal de 35, obtuvo.... ¡35!

Resultó interesante y algo ocurrente cruzarme, ya en la calle, con un amigo, comentar el suceso, y pedirle que desarrollara uno de los ejercicios que había practicado y resuelto con soltura Don Julio. La persona mencionada lo pudo concretar pero, con dificultades y siendo portador de tres décadas menos.

Hace 50 años, lejos estaba de imaginar poder asistir a un paciente de más de 100 años con un comportamiento intelectual y una integridad de personalidad que le permitiese registrar y recordar con precisión hechos recientes y lejanos. Los hermosos objetos de las paredes

del living fueron identificados con mejor precisión, sobre el origen de su adquisición, por Don Julio, que por el familiar presente, 30 años menor, con quien concretara las compras. Como imaginarán, ésta es una introducción de un hecho cada vez más frecuente: la longevidad, con conservación de los atributos intelectuales intactos. Al poder tener la ocasión de aglutinar informáticamente y estratificar la experiencia de los últimos 45 años de profesión, el asombro se incrementa cuando vemos crecer exponencialmente el promedio de vida de quienes concurren al consultorio. Muchos factores han coincidido; la mayoría vinculados al indudable progreso de la medicina preventiva, y al manejo más adecuado de padecimientos crónicos, como la hipertensión, las cardiopatías, la diabetes, o el EPOC. También a la tendencia, aún inconclusa, para corregir el sedentarismo y el tabaquismo, y al desafío, todavía incompleto también, para combatir la obesidad, o el consumo de alcohol y drogas.

Pero el interés del análisis de nuestro centenario amigo, no sólo pasa por la anécdota vivida y la realidad palpable que informa que, el promedio de vida crece en 2 años, cada 10 transcurridos, sino porque, contrariando nuestra persistente demanda, nuestro longevo amigo estuvo siempre con exceso de peso, mucho menos en la actualidad, y no hizo una actividad física ordenada, salvo las caminatas diarias cortas, mientras su seguridad en la marcha lo permitía. Esto nos asiste a ingresar en un tema de debate particular: la vigencia de la metáfora de los “cisnes negros” en medicina. Entre los siglos I y II, el poeta Juvenal acuñó una frase en latín: *“rara avis in terris nigro que simillima cygno”*. En español significa “ave rara en la tierra y muy parecida a un cisne negro”. Se presumía que el cisne negro no existía. Quería expresar la imposibilidad de un hecho. Luego, al descubrirse la existencia de cisnes negros en 1697 en Australia Occidental, nace la teoría de lo inesperado, de alto impacto, que plasma Nassim Nicholas Taleb, en su libro “El Cisne Negro” (Paidós 2011) ,al ocuparse de tales acontecimientos y los denomina Eventos Cisne Negro. Los ejemplifica con la irrupción de Internet, Google, la Primera Guerra Mundial, o el 11 de Setiembre.

Cuando conocí al paciente entrevistado era una persona de más de 100 kilos de peso, de 1 metro 70 centímetros de altura, hipertenso y con arritmia. Con gran preocupación efectué los pertinentes estudios y consultas, pero la lentitud del pulso (bradicardia) ya había sido consignada en revisiones previas. Mi pronóstico a futuro, no era muy optimista, y a pesar de tratarse de una persona razonable, criteriosa, y de una particular amabilidad y que cumplía puntillosamente con la medicación, la reducción de peso, sólo ocurrió con el paso del tiempo, y con la casi natural merma que se observa en los ancianos, llegando ahora a tener 80 kilos. Antes era un obeso, ahora un excedido solamente. Los médicos luchamos contra todos los factores de riesgo pero particularmente contra la obesidad. ¿Qué análisis podremos aplicar con nuestro centenario y simpático paciente?

Los factores citados, cuando son únicos, no tienen la gravedad de la combinación. Si estudiamos con extensas casuísticas poblacionales, la responsabilidad que le cabe al exceso de peso en la morbilidad y mortalidad de la población, nos encontramos con datos concluyentes. Alrededor del 45 por ciento de la población mundial tiene sobrepeso. De ese grupo, un tercio es directamente obeso. Los niños han duplicado el índice de masa corporal (IMC) y los adolescentes lo han triplicado en los últimos 20 años. Son elocuentes pruebas de su gravedad. Cuando se hace un hallazgo excepcional, con inevitable repercusión

mediática no debiera cambiar nuestra actitud y sólo hacernos reflexionar sobre la limitación de nuestros saberes y promover una actitud más humilde, respetando lo impredecible de los hechos fortuitos.

Con referencia a la longevidad se conoce que: 1º: el 81 por ciento de los centenarios son mujeres y en especial aquellas que tuvieron hijos luego de los 40 años. 2º: que la mayoría son delgados al evitar la plenitud gástrica, como se observa en las denominadas “zonas azules” del planeta; Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, y en la isla griega de Icaria. 3º: acostumbran hacer una corta siesta, (¡viva Santiago querido!) y 4º: en las denominadas zonas azules, hay un predominio de la alimentación vegetariana, con abundante batata, papa, tofu en Japón, o el ñame en Costa Rica, con el agregado del pescado y vino en Grecia.

En otros artículos nos ocupamos de la natural tendencia a asumir que, a pesar del tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo, los pacientes consideran que pueden repetir la longevidad lograda por sus padres, contrariando la lógica de que, al sumar riesgos potenciamos las indeseadas repercusiones. Sólo en ocasiones excepcionales, se ha demostrado la presencia del gen FOXO3A en linajes de familias muy longevas. Para finalizar, propongámonos extraer conclusiones del peculiar suceso vivido: 1º: cada vez será más frecuente enfrentarnos a la realidad de sujetos centenarios de lucidez envidiable. 2º: nuestras razones médicas cimentadas en enjundiosos estudios científicos, no debieran generar verdades taxativas: “No hay enfermedades sino enfermos”. 3º: los sucesos inesperados como la relación obesidad- longevidad de nuestro paciente tienen mucho impacto pero pobre significación estadística real. 4º: el concepto de los Eventos Cisne Negro deben conocerse pero no proyectarse como un suceso probable. 5º: luchemos racional y prudentemente para evitar los factores de riesgo y sobre todo su conjugación. Tengamos siempre presente que envejecemos, pero que: ¡101 años lúcidos son posibles!

Aclaración: El suceso descrito es absolutamente real, con la modificación del nombre, y solicitando la autorización para su publicación.